



OSATEK, S.A.

**INFORME DE
RESONANCIA MAGNÉTICA**

Centro: UNIDAD OSATEK
TXAGORRITXU
Dirección José Achótegui, s/n
(01009) VITORIA-GASTEIZ
Tel / Fax: 945007400 / 945007404
E-mail: rm.vitoria-gasteiz@osatek.es

Apellidos: GUINEATBANEZ DE GARAYO
Nombre: LUIS MARIA
Id: 1164816
F. Nac.: 15/05/1956

N Prueba: VI001-02-114716
Procedencia Hospital Donostia
H. DE DONOSTI
RADIOLOGICO DONOSTI
Méd. Solicitante: NAVIA ALVAREZ PEDRO

Exploración: 28/01/2019 08:20: RM - ANGIO - CEREBRAL
28/01/2019 08:20: RM - CRANEAL
Radiólogo: RODRIGUEZ-VIGIL JUNCO, BEATRIZ

MOTIVO DE CONSULTA: Control de fístula arteriovenosa dural del seno sigmoide derecho tratada endovascularmente 17 de septiembre de 2018

TÉCNICA

Sagital T1, coronal TSE (T2), axial T2, FLAIR, DWI y T2*. 3D TOF, MPR sin y con gadolinio

COMENTARIO

Se compara con estudio previo de septiembre de 2017.

En la actualidad se identifica material de embolización a la altura de la región posterior del seno sigmoide derecho objetivándose en las secuencias 3D-TOF vaso con flujo arterial que parece corresponder con rama de la arteria occipital derecha, asimétrica con respecto a la izquierda, de mayor calibre, que transcurre adyacente a la pared medial de la vena yugular interna derecha hasta el seno sigmoide en cuyo interior se ramifica. Únicamente observo flujo arterial en esta arteria dado que no es visible flujo arterializado en el resto del seno sigmoide ni tampoco en el seno transversal.

En el estudio con postcontraste se observa una estructura probablemente venosa en comunicación con la región más superior y posterior del seno sigmoide, por detrás del material de embolización, que sigue un trayecto transóseo hasta la región superficial a la escama occipital derecha. Es también asimétrica con respecto al lado contralateral.

No observo lesiones de nueva aparición en el parénquima cerebeloso ni cerebral occipital cercano

En el resto del estudio no hay otros cambios significativos persistiendo craniectomía frontotemporal izquierda con malla y discreto encéfalocele ya visible en el estudio anterior, que se acompaña de cambios glióticos malácicos sobre todo a la altura de lóbulo de la ínsula, opérculo frontal y giro y lóbulo temporal izquierdo. Retracción ventricular similar al estudio previo así como restos de hemosiderina subyacentes a la craniectomía.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

Material de embolización en la región posterosuperior del seno sigmoide derecho persistiendo dilatación asimétrica de rama de la arteria occipital derecha que es visible a través del agujero yugular hasta el interior del seno sigmoide, sin identificar en el estudio actual arterialización del flujo en este

seno. Rama venosa transósea que comunica con la región posterosuperior del seno sigmoide a través de la escama derecha del occipital, asimismo ligeramente asimétrica con respecto al lado contralateral. No observo complicaciones de nueva aparición

Estado del informe VALIDADO / Doctor/a RODRIGUEZ-VIGIL JUNCO, BEATRIZ

Id: 1164816

N. Prueba: ¡Error! Elemento de Autotexto no definido.

Nombre: GUINEA IBAÑEZ DE GARAYO, LUIS MARIA

Fecha informe : 30/01/19

Pág. 2 de 2

